

INDICADO POR:

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 227310422

ISAURA YOUKO MANAKO

IDADE: 69	PESO: 67	ALTURA: 1,56	PROFISSÃO: Aposentada (Bancaria)
SINTOMAS: não relata sintomas, realizou exame por influência do marido			
QUEIXAS: Sonolência logo após almoço			
MEDICAMENTOS: ASA 2 / Glibag / Dianibron / tixiti			
MÉDICO: Dra Camila			
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N			
EXERCÍCIO FÍSICO: caminhada pela manhã			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5		ALMOÇO: 5	LANCHE: N JANTAR: 18-19h
HORA QUE DORME: 22:30-23h		HORA QUE ACORDA: 5:30h	
COCHILHO: () S (X) N	DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE		
TEM FILHOS: () S (X) N	DORMEM NO QUARTO: () S (X) N		PET NO QUARTO: () S (X) N
BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N			
FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO/NOITE: 1x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não	MALLAMPATI:	IAH: 504cl/h	SPO2: 79%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: HAS / diabetes / colesterol			
CIRURGIAS: (N) NASAL (M) AMIGDALECTOMIA			
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (M) RESPIRATÓRIA (M) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA			
(N) ORTOPÉDICA	(N) NEUROLÓGICA	() OUTROS:	
POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N		SPO2 C/ CPAP:	PRESSÃO NO EXAME:
15/05/25 Avaliação - Localização Turbille 4-10 cm H ₂ O Do Wimp Tráide Natacha			
22/05/25 P=4,9 cm H ₂ O IAH: 3,6 cl/h Bem adaptada m de uso: 7h17' fuga: 3,2 l/m Natacha			
29/05/25 P=5 cm H ₂ O IAH=3,4 cl/h Bem adaptada m de uso: 7h15' *P=4 a 6 cm H ₂ O fuga: 3,8 l/m Natacha			

24/06/2025 P=4,2 cm H₂O

TAH=1,8 e 1 h

m de uso: 7h 29'

Queda: 34,11m

Bem adaptada

Quebrau feilho (D), esta
sintendo dor na
panturrilha

Natasha





CLÍNICA **OPUS**

OTORRINOLARINGOLOGIA
E ESPECIALIDADES

Indicado CPAP para
paciente Ismael Gomes Mendes
com quadro de SAOS grave,
AHH: 50,4 / hora.
grate.

05/05/25
Dra Camila C. Yassura
Otorrinolaringologista
Crm 125.478-RQE-35183

clínicaopus.com.br

de Jd Nova América:
Fernão Dias, 340 -Jd. Esplanada

Alergia e Imunologia
Cirurgia Plástica da Face
Endocrinologia
Endocrinologia Pediátrica
Fonoaudiologia
Otorrinolaringologia
Urologia

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala Epworth (8), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório acentuado (**50,4 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação da oxi-hemoglobina preservada (**79%**);
3. Latência para o início do sono normal (**4,5 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Diminuição da latência para o início do sono REM (**62,5 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono reduzida (**80,2 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Aumento do índice de despertares (**28,6 n°/h**) (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 normal (**1,6 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Aumento do percentual do estágio N2 (**58,4 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta normal (**17,7 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM normal (**22,3 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco moderado, constante, verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

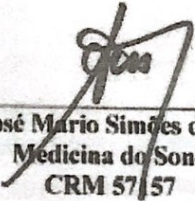
Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57